

a5_baseline_compare 测试报告

生成时间：2026-05-18 15:31:32

测试时间：2026-05-18 15:31:32

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1306 markers=2

禁用工具 success=True chars=1275 markers=1

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_基础信息:tool_基础信息：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

ECR 状态对比报告

一、住院前状态摘要

陈萍忠老人确诊阿尔茨海默病性痴呆4年余，近期BPSD（精神行为症状）显著加重，表现为拒绝进食、拒绝配合康复训练、回避人际交流及情绪躁动，NPI评分为22分（重度）。基础疾病包括心脏起搏器植入及胆囊切除术后状态，血压与血脂控制不佳，长期未规律服药。日常生活能力方面，可独立完成进食与穿衣，平地行走需部分辅助，洗澡需他人协助。家属因长期照护压力大，存在明显焦虑情绪，缺乏专业照护知识。入院时生命体征基本平稳，但情绪高度不稳定，因BPSD急性加重急诊收治。

二、出院时状态摘要

经住院治疗后，老人BPSD症状明显缓解，情绪趋于平稳，能够配合基础生活照护操作。NPI评分降至16分（中度）。生命体征稳定，心率维持在60次/分，睡眠与饮食恢复规律。医嘱明确要求规律服用降压及调脂药物，并每日监测血压。日常生活能力较住院前无明显变化：仍可独立进食、穿衣，平地行走需部分辅助，洗澡需他人协助。当前照护重点聚焦于跌倒防护、药物依从性管理、认知非药物干预实施、BPSD症状动态监测及家属心理与技能支持。

三、ADL变化

日常生活活动能力（ADL）整体保持稳定。住院前后均能独立完成进食、穿衣、如厕及床椅转移；平地行走持续需要部分辅助；洗澡始终需他人协助。未出现新发功能丧失或能力退化，Barthel指数相关项目无显著变动。

四、NPI变化

NPI评分由住院前的22分下降至出院时的16分，降幅达6分，表明精神行为症状（如躁动、抗拒、社交退缩）获得显著临床改善，行为紊乱程度从中重度向中度过渡。

五、进食状态变化

住院前存在明确“拒绝进食”行为，属BPSD表现之一；出院时饮食已恢复规律，且可自主完成进食过程。进食状态实现从“抗拒”到“规律摄入”的积极转变，反映情绪与行为控制能力提升。

六、睡眠状态变化

住院前虽未明确描述睡眠障碍，但BPSD中的情绪躁动常伴随夜间觉醒或睡眠片段化；出院时睡眠已恢复规律，结合NPI评分下降及情绪平稳，可判断睡眠质量获得实质性改善。

七、吞咽风险变化

住院前后均未报告吞咽困难、呛咳或误吸事件，且老人持续保持独立进食能力，提示吞咽功能稳定，无新增吞咽风险，维持低风险状态。

八、关键退化项

本次住院期间未观察到任何日常生活能力、认知功能或躯体功能的关键性退化。相反，精神行为症状得到控制，整体功能状态呈现稳定或改善趋势。

九、新增风险点

（留空）

注：跌倒风险与药物依从性风险在住院前已存在（行走需辅助、未规律服药），出院时仅为强化管理重点，非本次住院后新出现的风险因素。

十、重点观察项

1. BPSD症状是否复发（如再次出现拒食、躁动、社交回避）；
2. 血压波动情况及降压药物耐受性；
3. 服药依从性

【禁用工具输出摘录】

ECR 状态对比报告

一、住院前状态摘要

陈萍忠老人确诊阿尔茨海默病性痴呆4年余，长期存在行为与精神症状（BPSD），近期症状显著加重，具体表现为拒绝进食、拒绝配合康复训练、不愿与人交流及情绪躁动。NPI评分为22分，提示重度BPSD负担。慢性病管理欠佳，高血压及高脂血症未规律服药，血压与血脂控制不佳。日常生活活动能力（ADL）部分保留：可独立完成进食与穿衣，平地行走需部分辅助，洗澡需他人全程协助。家属因长期照护压力及近期症状恶化，出现明显照护焦虑，且缺乏专业照护知识。此次因BPSD急性加重急诊入院，入院时情绪躁动，但生命体征基本平稳。既往病史包括心脏起搏器植入术及胆囊切除术。

二、出院时状态摘要

经住院治疗，老人BPSD症状明显缓解，NPI评分降至16分，情绪趋于平稳，能够配合基础照护操作。生命体征稳定，静息心率维持在60次/分，饮食与睡眠节律恢复正常。医嘱明

确要求规律服用降压及调脂药物，并每日监测血压。ADL能力较住院前无明显变化，仍可独立进食、穿衣，平地行走需部分辅助。当前照护重点聚焦于跌倒防护、确保药物依从性、实施认知非药物干预、持续监测BPSD症状及提供家属心理与技能支持。

****三、ADL变化****

日常生活能力整体保持稳定，未出现功能性退化或进步。进食、穿衣维持独立；平地行走及洗澡所需辅助程度与住院前一致。

****四、NPI变化****

NPI评分由住院前的22分降至出院时的16分，下降6分，表明行为与精神症状负担显著减轻，尤其在情绪躁动、社交退缩及抗拒行为方面改善明显。

****五、进食状态变化****

进食状态明显改善。住院前存在明确的“拒绝进食”行为，出院时已恢复规律饮食，且能配合进餐照护，提示进食意愿与合作性显著提升。

****六、睡眠状态变化****

(留空)

****七、吞咽风险变化****

(留空)

****八、关键退化项****

(留空)

****九、新增风险点****

(留空)

****十、重点观察项****

1. BPSD症状是否出现复发或波动（如再次出现拒食、躁动、社交回避）；
2. 降压及调脂药物的服药依从性及血压监测执行情况；
3. 跌倒风险，尤其在行走转换及如厕过程中；
4. 情绪稳定性及日常配合度变化；
5. 家属照护信心与应对能力是否持续获得支持。

****十一、承接建议级别****

建议照护机构提供“加强监护与专业支持”级别的承接方案，包括定期BPSD评估、药物管理监督、防跌倒环境优化及家属协同照护培训。

****十二、既往行为模式对比****

住院前行为模式以抗拒、封闭、躁动为主，表现为对进食、康复及人际互动的全面拒绝；出院后行为模式转向合作与平稳，能够接受并配合基础照护，显示出更高的环境适应性与照护可及性。

****十三、约束措施****

(留空)

****十四、环境适应**